

1. ANAMNESIS

- Nombre (s) y Apellido (s):
- Vínculo con el/la paciente:

3. MOTIVO DE CONSULTA a. _____ b. _____ c. _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5. ANTECEDENTES REMOTOS DE LA ENFERMEDAD ACTUAL

6. ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES

Esquema de Vacunación Completo Sí ☐ No ☐

7. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS

Ginecológicos: Menarca _____ Regularidad: _____ Coágulos si/no Sangrado intermenstrual si/no

Fecha ultima menstruación: _____

Tiempo del periodo menstrual: Menopausia _____

Gestaciones: Cantidad: Parto: Vaginal Cesárea

Abortos: _____

Lactancia si/no Leucorrea si/no Dispareunia si/no SOP si/no

Métodos anticonceptivos si/no PAP:

Mamografía si/no Ecografía si/no FUM si/no

8. ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES

-Madre Viva? Sí ☐ No ☐ Edad: _____ Patología/Causa de Muerte: _____

-Padre Vivo? Sí ☐ No ☐ Edad: _____ Patología/Causa de Muerte: _____

Hermanos: Si ☐ No ☐ Cuántos: ♂: ♀:

Hijos: Si ☐ No ☐ Cuántos: ♂: ♀:

_____.

9. RESUMEN DE ADMISIONES PREVIAS EN LOS HOSPITALES O CONSULTORIO

_____.

10. HABITOS E INFLUENCIAS DEL AMBIENTE

Hábitos Fisiológicos

Ingesta: (buena en cantidad o calidad, buena en cantidad mala en calidad, tener en cuenta la patología de base: respeta dieta hiposódica en HT, respeta dieta hipoproteica en para IRC, respeta dieta hiposódica e hipoglucida para DM)

Digestión: molestias, náuseas, vómitos, disfagia, pirosis

Alteraciones del apetito: hiporexia, inapetencia, anorexia

Diuresis: volumen: número de micciones: Características de la orina (color, etc.):

Molestias (disuria, poliaquiuria, tenesmo, nicturia, etc.):

Catarsis: ¿Cuántas veces?: _____ Todos los días? Sí ☐ No ☐

Consistencia: Color: ¿Moco? ¿Sangre? ¿Pus?

Sexuales: Libido ☐ Sí ☐ No ☐ N° de parejas: Heterosexual? ☐ Sí ☐ No ☐

¿Medidas de protección?: _____

Sueño: Horas: Alteraciones:¿Le cuesta conciliar el sueño? ☐ Sí ☐ No ☐

¿Se despierta con frecuencia? ☐ Sí ☐ No ☐

¿Consumes algún fármaco hipnótico? ¿Sueño reparador? ☐ Sí ☐ No ☐

Actividad Física: ☐ Sí ☐ No ☐ ¿Qué tipo?

Hábitos Tóxicos:

-Tabaco: ☐ Sí ☐ No ☐ ¿Actualmente?: Por cuánto tiempo?: Cuánto?:

Tipo de tabaco:

-Alcohol: ☐ Sí ☐ No ☐ ¿Por cuánto tiempo?: Tipo: Cuánto?: Tipo de alcohol:

-Mate ☐ Tereré ☐ Otros: _____

12. REVISIÓN POR APARATOS Y SISTEMAS

-Cabeza: (dolor de cabeza/cefalea; dónde, duración, características, se exagera o calman con la tos, esfuerzo, o cambios de posición corporal?,, forma de inicio de la crisis dolorosa : insidioso o progresivo?, permanencia continua o intermitente?, presenta ataques frecuentes en el año?, se presenta al descanso?, , - ha sufrido de estados de pérdida de conciencia?, ha sufrido de algún episodio de epilepsia o convulsiones?, Recuerda la crisis o alguien que estuvo con usted le comento lo sucedido? fueron precedidos de auras? Ha experimentado traumatismo en alguna crisis?, ¿cuánto duró? Los ataques son semejantes? Diferenciar principalmente los síntomas y signos de un síncope vasovagal y cardiogenico de stokes adams; - do de episodios de mareos? Lo puede describir?)

-Ojos: ¿ (Agudeza visual - diplopía - escotomas - epifora/lagrimeo - fotofobia - dolor ocular - uso de lentes para visión cercana o lejana - ptosis palpebral? cambios recientes en la vista -)

-Oídos: (Agudeza auditiva - dolor / secreciones por el conducto, acúfenos, enfermedad inflamatoria auditiva previa)

-Nariz y Senos paranasales: ¿ (Sensación de obstrucción nasal o congestión, epistaxis/sangrado, sufre de rinitis o sinusitis, Número de resfríos en el año y en qué periodo o estación aparece, alergias nasales, sufre de algún trastorno del olfato)

-Boca y Garganta: (dolor de dientes - gingivorragias espontáneas o traumáticas - tiene extracciones dentarias - hemorragias o infecciones post extracciones dentarias - infecciones gingivales - abscesos dentarios - úlceras en la mucosa bucal (labios - palatino - yugal), estos tienen ardor o dolor?, dolor de gargganta - Laringitis - Presenta cambios de voz (ronqueras-disfonias), Ax. Deglutorias (disfagia - odinofagia- sialorrea-xerostomia/sequedad)

-Cuello: (sensación de tumoración o masa cervical - dolor de cuello - rigidez de nuca - Ax. De la movilidad cervical)

-Ganglios Linfáticos: (percibe la presencia de un o unos ganglios aumentados de tamaño (cervical, axilar, inguinal, epitroclear)

-Piel y Anexos: (presencia de lesiones elementales como erupciones, úlceras, tumores, cicatrices, cambios de pigmentación o textura de la piel, sufrió en algún momento ataques de ictericia/cambios de coloración en la piel a amarillenta, en ese momento como era el color de su orina, materia fecal) presentó prurito en la piel?, prurito localizado o generalizado, sudoración anormal/excesiva o nocturna, pérdida o aumento del crecimiento de los vellos, cambios en las uñas.)

-Ap. Resp.: (dolor torácico y su relación con la respiración, dificultad para respirar, tos, esputos o expectoraciones, hemoptisis, sensación febril, sensación de fatiga, chillidos de pecho)

-Ap. Cardiov.: (dolor de tipo precordial o retroesternal, relación con los esfuerzos físicos - digestión, respiración, emociones, sueño - este dolor calma con medicación sublingual? Y en cuanto tiempo?
- Tiene dificultad respiratoria debido al esfuerzo, es progresivo o no? ¿Hasta qué distancia puede caminar sin fatiga?, durante el descanso/sueño/ortopnea?, de aparición brusca o lenta? ¿Cuántas almohadas utiliza para dormir?- Tiene sensación de palpitaciones?, ingiere alguna medicación en ese momento y cómo responde? - edema en MI vespertinos - Es conocedor de ser portador de enfermedades cardiacas como soplos, HTA, u otros. ¿Realiza una mediación para ellos? Nombre, dosis, respuesta - Tuvo amigdalitis a repetición acompañado de ataques o dolores articulares en la niñez o adolescencia?.)

-Ap. Digest.: estado del apetito - digestión - comidas que no tolera - sensación de pirosis - ha sufrido de náuseas y vómitos (cantidad y características) - hematemesis? - ¿sufre de dolores abdominales? ¿Tienen relación con la ingesta? ¿Cómo se exacerban o se calman?

Ax. En el hábito defecatorio (constipación o diarrea - dificultad al defecar, pujos y tenesmo) - descripción de la defecación (veces por dia/semana, cantidad, consistencia, color, olor, hay presencia de gleras, pus o sangre) - sufre de constante sensación de flatulencias o meteorismo - aproximadamente cuánto ha crecido su abdomen en los últimos 6 meses.

-Ap. GenitoUr.: (Tiene alguna dificultad para la micción? - cantidad de orina en el momento y por día - Presenta incomodidades al orinar, como dificultad para iniciar o continuar la micción, disuria, tenesmo, polaquiuria, incontinencia, urgencia, retención, dolor o ardor, características de la coloracion de la orina (piuria, hematuria, coluria) características del chorro miccional - sufre de dolores lumbares o de costado abdominal?, edema de párpados, cara diurnos? - Antecedentes de enfermedades venéreas o sintomas de uretritis, recibió tratamientos o tuvo complicaciones? - Presencia de secreciones uretrales o vaginales (cantidad, color, olor, prurito? - número de embarazos, duración de cada uno, complicaciones durante el embarazo/ cadiaco/ renal/pulmonar), numero de abortos (espontaneos o provocados).

Autoexamen de mama? Presenta cambios o Ax.? ¿Pérdidas de secreción por pezón?

-Ap. Motor: En cuál de sus articulaciones presenta Ax? Que ax.? (Dolor, tumefacción, rubor, calor, limitación del movimiento, crujidos, entumecimientos o rigidez / en qué momento del día/ tiene relación con influencias estacionales o climáticas - compromiso vascular?) - son afectación de

pequeñas o grandes articulaciones? Simétricas/compromiso simultáneo o asimétricas?, ha recibido tratamiento? ¿Ha quedado con secuelas? - presenta dolores óseos o deformidades de nacimiento o adquiridas? Dolores o debilidades musculares? Amiotrofias? Accidentes de trauma óseo o muscular previos?

-Sist. Nervioso: (Ax. De la sensibilidad, sensorial, motilidad, funcional, de la marcha, convulsiones?

-Glándulas Endocrinas.: (ha sufrido de cefaleas o tx. Visuales? - Ax. Del crecimiento de manos y pies o miembros? - Ax. Importantes del peso (adelgazamiento obesidad) - Pérdida o alteración de los caracteres sexuales secundarios (vello axilar, pubiano, voz), presenta sintomatología de hipotiroidismo o hipertiroidismo? - ¿Se conoce diabetico? Presenta sintomatología de DM como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso?

11. CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS (CASE)

Macroambiente: Rural☐ Urbano☐

Microambiente: nº de personas que viven en la casa ____ Habitaciones ____

Materiales: piso _____ techo _____ paredes ____

Calidad y cantidad de las comidas _____

Cocina a: Gas☐ Inducción☐ Leña☐

-X años/meses/días atrás/ antes paciente refiere cuadro similar que....

No se conoce hipertenso, ni diabético. Conocido X patología desde hace X años/meses, tratado regular/irregularmente con.....

Agua: ESSAP☐ cauce☐ pozo (¿hierve?)☐ Cercanía con el baño: _____

-Baño: Moderno☐ Letrina☐ Distancia a la casa_____

-Escaridad: Primaria☐ Secundaria☐ Universitaria☐

-Nivel económico: Alto☐ Medio☐ Bajo☐

- ¿Conoce la vinchuca? Sí☐ No☐ ¿Te picó alguna vez? Sí☐ No☐

-Contacto con tosedor crónico: Si☐ No☐

-Animales Domésticos: Si☐ No☐ Especie y cantidad: _____

EXAMEN FÍSICO GENERAL

Sexo: ♂☐ ♀ ☐

Edad: de tantos años, si la edad cronológica coincide con la edad aparente Raza: no se dice.
Biotipo: Longilineo ☐ normolineo ☐ brevilineo ☐

Estado nutricional: IMC en %, saber la escala, mirar el abdomen. Puede ser

Eutrófico ☐ hipotrofico ☐ hipertrófico ☐

Estado de conciencia: Lucidez ☐ coma ☐

☐ Lucidez: Ubicado en tiempo, espacio y persona

☐ Vigil: ojos abiertos

☐ Coma

Facie: coloración, simetría, expresión

☐ Facie compuesta: si esta conservado

☐ Facie febril, lupica, cianótico, cushingoide, etc.: si no está conservado: _____

Lenguaje:

☐ Conservado (habla)

☐ No conservado (no se comunica, afasia, ACV, el hemisferio dominante es el afectado)

Actitud y Decúbito:

☐ Posición sentada: Sentado / Decúbito dorsal, lateral, ventral: Acostado

☐ Posición Activa: Indiferente (por sí solo), obligado (pudiendo cambiar de posición, solo puede adoptar una. Ej.: fractura), preferencial Posición

☐ Pasiva: Echado a la gravedad (coma, cuadripléjico)

Marcha:

☐ Normal,

☐ Conservada o eubasia (incapacidad de mantenerse de pie o caminar en una manera normal).
Marcha hemipléjica, paretico, parkinsonismo, tabetico

☐ No explorada

Llama la atención: ejemplo, paciente disneico con tiraje, una pierna más gruesa que la otra, las uñas en vidrio de reloj, cicatrices, herida con apósitos

Impresiona portador de una patología: Aguda ☐ Crónica ☐ Crónica agudizada ☐
Impresiona sana ☐

Preguntas sobre el dolor

1. Antigüedad: tiempo
2. Duración: agudo o crónico, breve, prolongado, intermitente, recidivante, etc.
3. Aparición: brusca o gradual
4. Localización
5. Irradiación
6. Carácter: opresivo, urente, lancinante, pulsátil, desgarrante, sordo, etc.
7. Intensidad
8. Atenuantes o agravantes
9. Horario y periodicidad
10. Síntomas que acompaña
11. Síntomas que preceden
12. Tratamiento

Preguntas sobre la fiebre

1. Antigüedad:
2. Inicio (brusco o gradual)
3. Graduación en cuantos grados
4. Duración
5. Momento del día
6. Terminación
7. Síntomas acompañantes: escalofríos, Sudoración, etc.
8. Tratamiento

Preguntas de piel

1. Antigüedad
2. Localización
3. Simetría
4. Zona expuesta al sol
5. distribución
6. Tipo
7. Numero
8. Tamaño
9. Forma
10. color
11. Bordes, límites
12. Superficie
13. Consistencia
14. Prurito o dolor (urente, punzante, cortante, transfixiante)
15. Síntomas acompañantes

Preguntas sobre osteoartr

- 1- Donde se presenta el dolor
- 2- Cuando se presenta el dolor? a- Posición b- Movimiento
- 3- Como empezó el dolor
- 4- Características e Intensidad
- 5- Manifestaciones asociadas: compromiso del estado general, compromiso de piel y faneras, compromiso de otros órganos
- 6- Circunstancias en la que aparece
- 7- Como evolucionó el dolor? Auto limitado, aditivo, migratorio, recurrente
- 8- Respuesta al tratamiento
- 9- Presencia de sintomatología inflamatoria local..... calor, rubor , impotencia funcional, rigidez
- 10- Grado de capacidad Funcional

Preguntas de Edema

1. Antigüedad
2. Evolución
3. Simetría
4. Localización
5. Coloración
6. Temperatura
7. Aspecto de la piel
8. Dolor
9. Consistencia
10. Vinculación con los movimientos y la posición
11. Síntomas que le acompañan

Preguntas de Disnea

1. Antigüedad
2. Te agitas? Te ahogas?
3. Aparición brusca o insidiosa Continua o intervalos libres
4. Atenuantes o agravantes
5. Grado de limitación
6. Síntomas que la acompañan

Preguntas de tos

1. Antigüedad
2. En qué momento del día?
3. Seca o húmeda? Si es húmeda, productiva?
4. Circunstancias de aparición
5. Intensidad o frecuencia
6. Síntomas acompañantes

7. Tratamiento

***expectoración**

1. Cantidad
2. Consistencia, viscosidad
3. Color y transparencia
4. Olor
5. sangre

Preguntas de cianosis

1. Antigüedad
2. Relación con el esfuerzo
3. Antecedentes de Enf broncopulmonar/Cardíaca
4. Síntomas acompañantes
5. Ingesta de nitratos (metaHb)
6. Tratamiento

Preguntas sobre Ictericia

1. Antigüedad
2. Evolución
3. Ingesta de medicamento hepatotóxico
4. Prurito?
5. Dolor?
6. Como es el color de tus desechos?
7. Síntomas acompañantes

Preguntas Debilidad

1. Antigüedad
2. Inicio (brusco o gradual)
3. Tiempo y secuencia de instauración
4. Zona del cuerpo
5. Momento del día
6. Síntomas acompañantes o precedentes

ECTOSCOPIA

1- PACIENTE DE SEXO:

- Masculino
- Femenino

2- ESTADO DE CONCIENCIA:

- Vigil
- Estupor
- Somnoliento
- Comatoso

3- ORIENTADO EN TIEMPO ESPACIO Y PERSONA

DESORIENTADO EN TIEMPO ESPACIO Y PERSONA

4- SU EDAD CRONOLOGICA... COINCIDE CON SU EDAD BIOLOGICA

5-TROFISMO:

- Normosomico
- Dismorfico a expensas de....

6-HABITO CORPORAL:

- Brevilineo
- Normolineo
- Longilineo

7-ESTADO NUTRICIONAL:

- Hipotrofico
- Obesidad
- Eutrófico
- Raquítico
- Sobrepeso
- Caquético

8-FASCIES:

- Compuesta
- Cianótica
- Cushingoide
- Somnolienta
- Ictericia
- Acromegalia
- Dolorosa
- Mongoloide
- Sardónica
- Rubicunda/febril
- Hipotiroideo
- Miastenica
- Anemia/pálida
- Hipertiroidea
- Asimétrica a expensas de....

9-ACTITUD Y DECUBITO:

Adopta en el lecho la posición de:

- Decúbito dorsal
- Decúbito lateral
- Decúbito ventral
- Decúbito semisentado o sentado en cama

- . Activo indiferente/preferencial
- . Obligado
- . Pasivo

10-MARCHA:

- Conservada
- Cerebolosa (Ebrio)
- Atáxica
- Parkinsoniana

11-QUE NOS LLAMA LA ATENCION

12-QUE IMPRESIONA

- Patología Aguda
- Patología Cronica
- Patología crónica agudizada